PROTOCOLLO 83

Valutazione e gestione dei DTM dopo colpo di frusta

Gestire i sintomi mandibolari nei pazienti con trauma cervicale

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta	DTM post traumatico	8 a 10 minuti	2 sedute a settimana

Indicazioni

- ✓ Dolore mandibolare dopo incidente
- ✓ Dolore cervicale post traumatico
- ✓ Cefalea e vertigini associate

Controindicazioni e precauzioni

- ! Segni di insufficienza vascolare (vertigini, diplopia, disartria, disfagia)
- ! Instabilità cervicale sospetta (traumi, artrite reumatoide)
- ! Sintomi neurologici agli arti superiori
- ! Trauma cervicale recente non valutato dal medico

Posizionamento

Paziente: supino, capo in posizione neutra.

Fisioterapista: alla testa del lettino.

Esecuzione passo dopo passo



Sicurezza
Verifica che il medico abbia escluso fratture e instabilità.



Valutazione
Esame DC/TMD e cervicale completo.



Gestione
Educazione, esercizio graduale e terapia manuale delicata.



Monitoraggio
Fattori psicosociali e recupero funzionale.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Fase iniziale	gestione del dolore e movimento
Progressione	esercizio graduale
Rivalutazione	ogni 4 sedute

Criteri di rivalutazione

DOLORE CERVICALE (NRS)
____ / 10
a riposo e in movimento

MOBILITÀ
____°
rotazione o flessione

SINTOMI MANDIBOLARI
Migliorati / Invariati
dopo il trattamento

Punti chiave

- ✓ Approccio graduale e rassicurante
- ✓ Integra collo e mandibola
- ✓ Attenzione ai fattori psicosociali

Errori da evitare

- ! Trattamento intensivo precoce
- ! Ignorare i segni di allarme
- ! Trascurare il carico emotivo del trauma

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Movimento graduale	Mobilità cervicale e aperture lente nel range confortevole	2 volte al giorno

! **Nota clinica.** I DTM dopo trauma cervicale richiedono un approccio integrato e la collaborazione con il medico.

Bibliografia essenziale

1. La Touche R. et al. The effects of manual therapy and exercise directed at the cervical spine on pain and pressure pain sensitivity in patients with myofascial temporomandibular disorders. J Oral Rehabil. 2009;36(9):644–652.
2. Jull G.A., O'Leary S.P., Falla D.L. Clinical assessment of the deep cervical flexor muscles: the craniocervical flexion test. J Manipulative Physiol Ther. 2008;31(7):525–533.